ST. LUKE'S ICU ／ EXECUTIVE SUMMARY

PICSとICU退室後のフォロー — 要約

解説「PICSとICU退室後のフォロー」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 ／ 対象：研修医・専攻医・看護師 ／ 最終更新 2026-10-09

1 持ち帰る3点

詳しく

入室の日から動いている

資源は在室中の上流（ABCDEF・浅い鎮静・せん妄予防）に置く。ただし「それで防げる」とは説明しない

退室のときに測って渡す

MRC・握力・嚥下・向精神薬を書き、病棟へ4項目（リハビリ・離床・栄養・残るリスク）を手渡す

足すより継ぐ

外来や専門役割を足すより途切れを埋める。短い評価を3・6・12か月に繰り返し、家族には接点を複数置く

2 PICSは傘 — 半年後も残る前提で退室を設計する

詳しく

領域	頻度の目安
ICU関連筋力低下	人工呼吸患者の25〜75%。1年後も最大筋力は健常対照の約50%減
抜管後嚥下障害	36〜44%、6か月後もなお23%
新しい痛み	退室3か月で33.2%、最多は肩（42.2%）
抑うつ・不安・PTSD	25〜46%・約30%・約20%。妄想的記憶は38.5%で、その約6割はせん妄と診断されていない
家族（PICS-F）	家族の20〜60%。1か月で44.9%が離職、1年で36.7%が貯蓄を失う

- **長期の予後を最も決めるのは入室前の状態**：90日後のフレイルの最強の予測因子は発症前のCFS（aOR 2.03）。入室0〜24時間に家族から発症前の生活を聞いて書く

3 ICUで防ぐ — 上流は必要条件だが十分条件ではない

詳しく

- **ABCDEFバンドルは実施した分だけ効く**：遵守が高いほどせん妄・人工呼吸期間・再入室・院内死亡が減る（15,000人超）。認知の手当ての窓は入室から最初の48時間（深鎮静とベンゾジアゼピンを避ける）
- **それでもPICSは消えない**：遵守97%どうしの比較で、12か月に動いたのはIADLとQOLだけ。認知・PTSD・生存は関連しなかった
- **量を増やす設計は負けた**：高蛋白2.0 g/kg/日は180日QOLを悪化（PRECISe）、離床量2.75倍でも12か月まで差なし（EVER）。蛋白は1.3 g/kg/日を上限に、離床は時間ではなく到達段階で見る

4 退室のときに測って書き、4項目を手渡す

詳しく

入室0〜24時間：家族から発症前CFS・ADLを聞く（新規の障害と元からの障害を分ける唯一の手段）

▼

在室中

- 毎シフトRASS→CAM-ICU、身体抑制の有無
- 協力できたらMRC sum score・握力
- 抜管直後に嚥下スクリーニング、陽性は言語聴覚士へ

退室時

- MRC 48未満はCIW、55以下は予後の閾値。握力（男11・女7 kg未満）も書く
- 病棟へ：リハビリ計画・離床目標・栄養目標・残るリスク

▼

退院時：ICUで始めた向精神薬に適応と中止計画を1行書く（新規処方の42.8%に裏づけ診断の記録なし）

緊急ICU再入室（2.9%）の約半数は退室後5日以内で、院内死亡は3.8倍（JIPAD 69,594件）。病棟での見守りは最初の5日に集中させる

5 退室後は2段階で、3・6・12か月に繰り返す

詳しく

段	身体	認知	精神
Step 1（全員・退院後3か月）	TUG＋握力	Mini-Cog＋ANT	PHQ-4＋GAD-2
Step 2（陽性の領域だけ）	2MWT/6MWT＋SPPB	TMT A-B＋MoCA/MMSE	PHQ-8＋GAD-7＋IES-R/PCL-5

- **精神は1回の陰性で終えない**：敗血症生存者のPTSDの26%は後から発症する。「ICUで何が見えていたか」「新しい痛みは、肩は」を直接聞く
- **優先するのは**入室前に自立していた60〜79歳、併存疾患が多い患者（FCI 2以上でのみリハビリでQOLが改善）

6 「足す」より「継ぐ」

詳しく

- **単発の場や専門役割を足す型は陰性か有害**：ICUダイアリーは3か月PTSDを減らさず、退室後の多職種コンサルテーション（Suivi-Rea）は1年後の不良転帰を増やし（調整OR 1.49）、家族ナースの新設（FICUS）は全8アウトカムで差なし
- **外来を置くなら**院内（身体・認知・精神）と地域をつなぐハブにする。予後改善は約束しない

7 家族はPICS-Fの当事者

詳しく

- ☐ ①入室後数日以内に**家族のニーズ**を把握
- ☐ ②退室時（死亡時）に**支援カード**を渡す
- ☐ ③転棟後に**電話を1本**入れる
- ☐ ④退院後3か月以内に**フォローの会話**（6か月IES-R −6.8）
- ☐ 面会を開き**構造化した家族教育**と組む（1年時PTSD 30.5%→21%）
- ☐ 遺族には**別建て**の支援（同じ伴走で悪化した）

出典：本編の主要文献（Singapore Med J 2026；Intensive Care Med 2024〜2026；Crit Care 2023・2026；Crit Care Med 2019・2026；Lancet 2024；日集中医誌 2025 ほか）。頻度は研究ごとに尺度と時点が違うので、本

編と原著で確かめてください。